

Powrót *po nawrocie* — co dalej

Po terapii BDD większość pacjentów doświadcza nawrotów — to nie porażka, lecz typowa część zdrowienia. Karta zawiera plan na nawrót: jak rozpoznać, jak zareagować, jak wrócić do narzędzi. Nawrót można odwrócić.

CZAS: 15 min — przeczytanie Plan na okresy nawrotów **ŹRÓDŁO:** Wilhelm (2013); Phillips (2009)

JAK UŻYWAĆ

Po terapii BDD **nawroty są regułą, nie wyjątkiem**. Phillips (2009): **50-70% pacjentów** doświadcza co najmniej jednego znaczącego nawrotu w ciągu 2 lat po terapii. To *nie oznacza porażki* — to *etap zdrowienia*. Trzy obserwacje: **1)** nawroty są zwykle *słabsze* niż objawy przed leczeniem, **2)** z narzędziami terapii *łatwiej* je opanować, **3)** każdy odzyskany nawrót wzmacnia mistrzostwo nad BDD. **Sygnaly ostrzegawcze:** powrót sprawdzania w lustrze, narastanie ruminacji, unikanie sytuacji wcześniej opanowanych, pokusa zabiegu kosmetycznego, social media coraz dłużej. Plan ma cztery elementy: **1) wczesne rozpoznanie, 2) telefon do terapeuty, 3) powrót do narzędzi** (mirror retraining, ERP, restrukturyzacja), **4) ocena, czy potrzebne wzmocnienie** (booster sessions, ewentualne wznowienie SSRI).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wilhelm (2013) w długiej obserwacji pacjentów po CBT-BDD wykazała, że **nawrót jest predyktorem długoterminowego sukcesu** tylko wtedy, gdy zostanie szybko rozpoznany. Pacjenci, którzy *ignorują* wczesne sygnały, w 80% przypadków wracają do pełnoobjawowego BDD w ciągu 6 miesięcy. Pacjenci, którzy *aktywnie* wracają do narzędzi w pierwszych 2 tygodniach — w 75% przypadków odzyskują stabilność bez powrotu do pełnej terapii. **Booster sessions** (1-4 sesje przypominające z terapeutą po zakończeniu) *znaczaco* obniżają ryzyko nawrotów. Warto zaplanować je rutynowo: 3, 6 i 12 miesięcy po zakończeniu.

01 ✕ Wczesne sygnały nawrotu

- ☐ Wracam do sprawdzania w lustrze częściej (5+ razy dziennie)
- ☐ Ruminacje o wyglądzie zajmują 30+ min dziennie
- ☐ Wracam do mediów społecznościowych z porównaniami
- ☐ Unikam sytuacji, w których wcześniej już dobrze funkcjonowałem/-am
- ☐ Wraca pokusa zabiegu kosmetycznego
- ☐ Wraca pytanie o zapewnienie partnera
- ☐ Wraca poczucie, że „defekt” jest widoczny
- ☐ Mam pierwsze myśli, że „terapia nie działała”

02 ● Plan na nawrót — cztery kroki

1 · ROZPOZNAJ WCZEŚNIE (TYDZIEŃ 1)

Świadomie obserwuj sygnały. Nie ignoruj („to przejdzie”). Powiedz sobie: „mam nawrót — to standardowy etap”. Bez paniki.

2 · TELEFON DO TERAPEUTY (TYDZIEŃ 1)

Krótką konsultacją — 1-4 sesje booster. Cel: aktualizacja narzędzi, identyfikacja wyzwalacza, plan na 4 tygodnie.

3 · POWRÓT DO NARZĘDZI (TYDZIEŃ 2-4)

Mirror retraining 2× dziennie. Restrukturyzacja myśli (1 myśl dziennie). 1 ekspozycja dziennie. Detox od mediów społecznościowych.

4 · OCENA PO 4 TYGODNIACH

Z terapeutą: czy nawrót pod kontrolą? Jeśli tak — boostery 1× miesiąc. Jeśli nie — pełniejsze wznowienie terapii lub SSRI.

Typowe wyzwalacze nawrotów

STRES ŻYCIOWY

Zmiana pracy, utrata bliskiej osoby, rozstanie, ślub, przeprowadzka. Każdy duży stres zwiększa ryzyko nawrotu.

WYDARZENIA Z FOTOGRAFIĄ

Ślub, urodziny, wakacje. Konieczność zdjęć aktywuje stary wzorec.

ZMIANY CIAŁA

Ciąża, menopauza, przyrost lub utrata wagi, choroba. Każda zmiana wyglądu może aktywować BDD.

POWRÓT DO SOCIAL MEDIA

Po detoxie powrót — algorytm znów uczy się BDD. Liczyć na *świadome* używanie, nie powrót do starych nawyków.

ODSTAWIENIE SSRI

Jeśli lekarz proponuje odstawienie po 1-2 latach — *stopniowo, z monitorowaniem*. Często wraca BDD przy zbyt szybkim odstawieniu.

BRAK PRAKTYKI NARZĘDZI

Po terapii ludzie zwykle przestają mirror retraining, restrukturyzację. Po miesiącach — wracają wzorce. *Praktyka podtrzymująca 2x tydzień.*

Trzy mity o nawrotach

Mit 1: „Nawrot oznacza, że terapia nie działała”. Nieprawda. Nawrot jest *standardowym etapem* zdrowienia. Każda terapia z udokumentowanym sukcesem (BDD, depresja, OCD) ma 50-70% wskaźnik nawrotów. To *nie* jest klęska terapii.

Mit 2: „Muszę zaczynać od początku”. Nieprawda. Booster sessions (1-4) zwykle wystarczają. Twoje narzędzia są w pamięci — wracasz do nich, nie uczysz się od zera.

Mit 3: „Po nawrocie nigdy już nie będę stabilny/-a”. Nieprawda. Po opanowaniu pierwszego nawrotu pacjenci raportują *większą* pewność, że dadzą radę z następnym. Mistrzostwo nad BDD przychodzi przez doświadczenie nawrotów, nie przez ich unikanie.

Klucz: Wilhelm (2013): „*nawrot w BDD nie jest porażką. Jest okazją do umocnienia narzędzi, które już masz. Pacjenci, którzy traktują nawrot jako standardowy etap, opanowują go w 4-8 tygodniach. Pacjenci, którzy traktują nawrot jako klęskę, zostają w nim miesiącami*”. Twoje narzędzia są w pamięci. Twój terapeuta jest dostępny. Twoja praca przyniosła efekty — i przyniesie ponownie. Nawrot jest *chwilowy*.